Dynamiques Systémiques entre Précarité et Santé Publique en Belgique : Analyse Épidémiologique à 360° et Modélisation Prospective des Politiques d'Austérité du Gouvernement Arizona (2025-2029)

Introduction : L'Indissociabilité des Déterminants Sociaux et de l'Infrastructure Sanitaire

L'architecture de la santé publique au sein d'une nation contemporaine ne saurait se circonscrire à la seule évaluation de ses infrastructures médicales, de la densité de son maillage hospitalier ou de l'avancée de ses technologies cliniques. Elle s'ancre fondamentalement, et de manière indissociable, dans les déterminants sociaux, économiques et environnementaux qui façonnent les trajectoires de vie de ses citoyens. La relation dialectique et synergique entre la précarité et la santé constitue l'un des axiomes les plus rigoureusement documentés en épidémiologie sociale et en économie de la santé. La pauvreté engendre la morbidité par le biais de la privation matérielle systémique, de l'exposition accrue aux risques environnementaux, et de l'accumulation d'une charge allostatique — l'usure physiologique liée au stress psychosocial chronique. Réciproquement, la dégradation de l'état de santé physique ou mental précipite la chute dans la précarité en réduisant drastiquement la capacité de gain, en désinsérant l'individu du marché du travail, et en augmentant exponentiellement les dépenses contraintes liées aux soins.

En Belgique, cette dynamique systémique de vases communicants se trouve, en cette année 2026, à un point d'inflexion sociopolitique et macroéconomique critique. Le paysage institutionnel et socio-économique national est en cours de redéfinition profonde suite à l'entrée en fonction du gouvernement fédéral dit « Arizona ». Cette coalition, dirigée par le Premier ministre Bart De Wever, a prêté serment au début de l'année 2024, consécutivement aux élections, et a présenté sa déclaration gouvernementale exhaustive à la Chambre des représentants en février 2025.[1] Ce gouvernement déploie un programme de réformes structurelles particulièrement ambitieux, d'inspiration résolument néolibérale, justifié par l'impératif perçu de consolidation budgétaire face aux injonctions européennes et par la volonté stratégique d'atteindre un taux d'emploi national de 80 % d'ici l'horizon 2029.[2]

L'accord de gouvernement, fruit de négociations complexes, prévoit un ajustement budgétaire

massif et transversal de 23,3 milliards d'euros sur la durée de la législature, un effort de restriction financière sans précédent depuis la crise financière de 2008.[5] Cette politique s'appuie principalement sur une révision restrictive des filets de sécurité sociale, une flexibilisation extrême du marché du travail, une limitation temporelle stricte des allocations d'insertion et de chômage, ainsi qu'une maîtrise percutante des dépenses allouées à l'assurance maladie-invalidité.[4] L'effort budgétaire total est programmé pour s'accomplir sans augmenter la pression fiscale globale sur les revenus du capital ou sur le Produit Intérieur Brut (PIB), traduisant une volonté de faire porter le poids de l'ajustement sur la réduction des dépenses publiques et la refonte des transferts sociaux.[5]

L'analyse scientifique et prospective de ces orientations politiques nécessite impérativement une approche à 360 degrés. Il convient de dépasser les simples projections macroéconomiques ou comptables pour investir les champs concrets de la morbidité différentielle, de la mortalité prématurée, de l'accessibilité financière aux soins, et de la cohésion du tissu social. Les politiques d'austérité budgétaire — bien qu'elles visent théoriquement la pérennité financière et institutionnelle de l'État central — se traduisent historiquement et empiriquement par une reconfiguration périlleuse des risques sociaux. Elles tendent à transférer la charge de la dette publique macroéconomique vers les vulnérabilités microéconomiques, individuelles et locales, exacerbant les inégalités existantes.[8]

Le présent rapport dresse un état des lieux exhaustif, fondé sur les données probantes, de la situation sanitaire et sociale de la Belgique à la charnière des années 2024-2026. Il s'attache ensuite à déconstruire les mécanismes juridiques, économiques et sociaux de l'accord de coalition Arizona. Enfin, il modélise avec rigueur les effets épidémiologiques de premier, de second et de troisième ordre de ces réformes structurelles sur la santé publique globale, sur la pérennité de l'infrastructure de solidarité nationale (notamment les soins de santé et l'aide sociale locale), et sur la stratification sociale du pays pour la décennie à venir.

État des Lieux Épidémiologique et Sociologique de la Belgique (2024-2026)

Pour mesurer avec acuité l'impact potentiel des nouvelles trajectoires politiques et budgétaires, il est épistémologiquement indispensable d'établir une ligne de base épidémiologique et sociologique rigoureuse. Les données récentes compilées par les instituts fédéraux de santé publique (Sciensano) et de statistique (Statbel) mettent en exergue une société belge traversée par de profonds clivages socio-économiques. Ces clivages ne relèvent pas du simple inconfort matériel, mais se traduisent par des inégalités de destin biologique irréfutables.

L'Espérance de Vie : Un Marqueur de Prospérité Masquant des Fractures Territoriales

Les données démographiques et épidémiologiques agrégées par l'institut Sciensano révèlent, à

première vue, une dynamique paradoxale et globalement positive. En 2024, l'espérance de vie à la naissance a atteint un niveau record en Belgique, s'établissant à 82,4 ans, effaçant ainsi définitivement les régressions et les surmortalités traumatiques observées durant les vagues successives de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2022.[10] Bien que la Belgique enregistre une légère sous-mortalité globale de +0,4 % en 2025 par rapport aux modèles statistiques prédictifs (et ce, malgré des épisodes intenses d'épidémies de grippe ayant causé un surplus ponctuel de décès), cette espérance de vie moyenne masque des fractures territoriales, genrées et sociales d'une profondeur préoccupante.[11]

L'analyse géographique intra-nationale démontre une asymétrie marquée entre les entités fédérées, reflétant de facto les disparités historiques de prospérité économique, de désindustrialisation et d'infrastructure sociale. Les données comparatives illustrent ce gradient géographique de manière univoque.

Entité Géographique (Données 2024)	**Espérance de Vie Globale (Années)**	**Espérance de Vie des Femmes (Années)**	**Espérance de Vie des Hommes (Années)**
Moyenne Nationale (Belgique)	82,4	84,4	80,3
Région Flamande	84,1	86,1 (estimation dérivée)	82,1 (estimation dérivée)
Région de Bruxelles-Capitale	82,1	Donnée sous-jacente en stagnation	Donnée sous-jacente en stagnation
Région Wallonne	80,7	Inférieure à la moyenne nationale	Inférieure à la moyenne nationale
Communauté Germanophone	82,1	84,1	80,2

Sources : Synthèse des rapports annuels de Sciensano et Statbel.[10]

Il est crucial d'analyser ces chiffres au-delà de la simple moyenne. L'année 2023 a vu, pour la première fois de l'histoire démographique belge, l'espérance de vie des hommes franchir le seuil symbolique des 80 ans.[10] Toutefois, la Région de Bruxelles-Capitale a connu une stagnation inquiétante en 2024, avec même une très légère baisse observée chez les femmes

(-0,09 an), contrastant avec la Région flamande qui a enregistré une augmentation notable (+0,91 an pour les hommes et +0,86 an pour les femmes).[10]

À l'échelle provinciale, l'écart se creuse de manière encore plus spectaculaire. L'écart entre la province affichant l'espérance de vie la plus élevée (le Limbourg, en Flandre) et celle accusant l'espérance de vie la plus faible (le Hainaut, en Wallonie) s'élève à 5,1 ans pour la population masculine et à 3,4 ans pour la population féminine.[10] Ces chiffres illustrent parfaitement l'empreinte de la désindustrialisation, du chômage structurel et de la pollution environnementale qui frappent les anciens bassins miniers et sidérurgiques.

Le Gradient Socio-Économique et les Pathologies d'Usure

Au-delà de la stricte géographie, le déterminant le plus puissant et le plus universel de la mortalité prématurée en Belgique demeure le niveau de diplôme, qui agit comme le proxy statistique le plus fiable du statut socio-économique global d'un individu. Les recherches de Sciensano confirment la persistance d'un gradient socio-économique massif : l'espérance de vie, et plus spécifiquement l'espérance de vie en bonne santé (sans incapacité majeure), s'effondre proportionnellement à la baisse du niveau de qualification.[10] Les individus appartenant aux groupes socio-économiques défavorisés accumulent les désavantages : emplois physiquement exigeants, environnements de vie dégradés, comportements de santé à risque induits par le stress, et accès différencié à la médecine préventive.

En 2023, les statistiques de mortalité indiquent que près de la moitié des 111 255 décès enregistrés étaient imputables à deux grandes catégories nosologiques : les tumeurs ou cancers (27 337 décès) et les maladies de l'appareil circulatoire ou cardiovasculaires (26 064 décès).[12] L'étiologie de ces pathologies est intrinsèquement liée aux conditions de vie matérielles. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne par ailleurs que quatre cas de cancer sur dix sont considérés comme évitables, car provoqués par des facteurs de risque liés au mode de vie et à l'environnement.[12] Or, l'adoption de modes de vie préventifs (alimentation de haute qualité nutritionnelle, activité physique régulière, sevrage tabagique, évitement des perturbateurs endocriniens) est fortement corrélée au capital culturel et financier. La pauvreté agit comme une contrainte systémique qui entrave la capacité des individus à investir dans leur capital santé à long terme.

La Précarité Multidimensionnelle et la Vulnérabilité Monétaire

La santé d'une population est le reflet direct et implacable de sa sécurité matérielle et de sa projection dans l'avenir. À l'orée de l'année 2026, la pauvreté et l'exclusion sociale maintiennent une emprise structurelle sur une frange substantielle de la population belge. L'indicateur européen mesurant la faible intensité de travail au sein des ménages (LWI - Low Work Intensity) s'établit à 11,0 % en 2025 (contre 12,9 % en 2019), tandis que le taux de risque de pauvreté monétaire (AROP - At Risk Of Poverty) se chiffre à 10,9 % (contre 14,8 % en 2019).[14]

Bien que ces statistiques macroéconomiques globales témoignent d'une légère amélioration

par rapport à la décennie précédente, elles diluent et invisibilisent des vulnérabilités micro-sociologiques aiguës. Le niveau d'éducation agit à la fois comme un bouclier protecteur et comme un catalyseur de déclassement social en cas de crise. Les enquêtes sur la pauvreté subjective démontrent qu'elle frappe 25,2 % des personnes peu diplômées, contre 16,4 % de celles ayant un niveau d'éducation moyen, et seulement 8,1 % des individus disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur.[14]

Par ailleurs, l'isolement social et familial, notamment par le biais de la croissance continue des familles monoparentales, accentue de manière exponentielle l'exposition à la précarité multidimensionnelle. L'Indice de Situation Sociale (ISS) calculé pour la Wallonie en 2025 démontre que les situations de dépendance fonctionnelle et la prévalence des maladies chroniques augmentent structurellement au sein des populations isolées.[15] L'IWEPS (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) confirme que les maladies chroniques génèrent des conséquences délétères sur la perception subjective de la santé, sur la capacité à assumer les actes de la vie quotidienne, et induisent une dépendance accrue aux soins, créant un fardeau financier insoutenable pour les ménages à revenu unique.[15]

L'Érosion de l'Accessibilité Financière : Le Phénomène du Renoncement aux Soins

La métrique la plus directe, la plus sensible et la plus symptomatique pour évaluer l'impact de la précarité monétaire sur l'efficacité d'un système de santé publique réside dans la mesure du taux de renoncement ou de report de soins de santé pour des raisons exclusivement financières. Bien que les indicateurs européens standardisés (SILC) rapportaient des chiffres lissés et historiquement bas avant la rupture de série de 2019 [16], le rapport exhaustif publié par l'Institut Solidaris (édition 2025) dessine une réalité de terrain infiniment plus alarmante, témoignant d'une urgence sociale aiguë qui fissure le mythe de la couverture universelle belge.

En 2025, les données révèlent que 41 % de la population belge francophone a été contrainte de renoncer à au moins un soin médical ou acte de prévention au cours des douze mois précédant l'enquête.[17] Ce chiffre global de renoncement, bien qu'en très légère décrue par rapport au record absolu de 2019 (qui culminait à 48 %), masque une hétérogénéité sociale violente et une détérioration rapide pour des sous-groupes démographiques spécifiques.[17]

Profil Sociodémographique et Facteur de Vulnérabilité	Taux de Renoncement ou Report de Soins (2025)	Évolution Temporelle et Observations Cliniques
Moyenne globale (Population Francophone)	41 %	Augmentation structurelle notable depuis 2015 (où le

		taux était de 32 %)
Femmes	48 %	Persistance d'un écart majeur de 15 points par rapport aux hommes (33 %) [17]
Étudiants (Population jeune en formation)	47 %	Dégradation critique : Hausse de 5 points en un an, et de +21 points sur onze ans [17]
Familles Monoparentales	60 %	Constitue la configuration familiale la plus exposée à la précarité sanitaire [17]
Personnes au Chômage (Spécifique Santé Mentale)	37 %	Hausse fulgurante de 16 points concernant le seul renoncement aux soins psychologiques [17]
Pensionnés / Seniors	37 %	Tendance à la précarisation sur le long terme (+25 points d'augmentation historique) [17]

Cette cartographie détaillée du renoncement révèle une défaillance systémique de l'État social protecteur.[17] Historiquement, le renoncement aux soins en Belgique se concentrait sur des spécialités onéreuses et structurellement mal remboursées par l'assurance obligatoire, telles que la dentisterie prothétique ou l'ophtalmologie (lunetterie). Or, l'évolution contemporaine démontre que la barrière financière s'étend désormais aux soins de première ligne (médecine générale), à l'observance thérapeutique (achat de médicaments sous prescription), et, de manière particulièrement foudroyante et dévastatrice, à la santé mentale.[17]

Les données de Solidaris indiquent que plus d'un étudiant sur quatre (26 %) renonce aujourd'hui à consulter un psychologue ou un psychiatre de première ligne en raison du coût inabordable des consultations, un chiffre en hausse vertigineuse de 10 points en une seule année.[17] Cette privation de soins précoces illustre la constitution d'une immense "dette de santé publique" latente. Cette dette financière et physiologique grèvera inévitablement les comptes publics et hospitaliers à moyen et long terme, lorsque ces pathologies psychiques et somatiques non traitées à un stade ambulatoire se mueront inexorablement en urgences chroniques ou aiguës nécessitant des hospitalisations lourdes.[17]

La Crise Endémique de la Santé Mentale : Le Cercle Vicieux de la Précarisation

Le Baromètre du bien-être publié à l'automne 2025 par le SPF Santé publique, ainsi que les vastes enquêtes menées par la Mutualité Chrétienne (MC), corroborent un effondrement psychologique collectif : l'indicateur global de bien-être subjectif des Belges a atteint son niveau historique le plus bas depuis 20 ans.[20]

Le rapport scientifique "Re-InVEST", soutenu financièrement par le SPP Politique scientifique (BELSPO), documente formellement la spirale pernicieuse et bidirectionnelle qui lie inextricablement la santé mentale et la précarité matérielle. Les entretiens qualitatifs et les analyses quantitatives démontrent que la pauvreté provoque un effondrement du bien-être mental et favorise l'apparition de troubles psychiatriques graves.[22] Cette détresse est générée par l'angoisse financière continue, le calcul obsessionnel des dépenses de subsistance, l'insécurité résidentielle, l'isolement relationnel, et l'humiliation sociale inhérente au statut d'assisté. Symétriquement, l'irruption de la maladie mentale désinsère brutalement l'individu du marché du travail compétitif, épuise ses ressources cognitives, et l'enferme durablement dans une pauvreté matérielle chronique.[22] Les personnes en situation de pauvreté sont presque invariablement confrontées à une accumulation de handicaps sociaux qui rend toute résilience psychologique exceptionnellement ardue.[22]

L'Architecture Socio-Économique du Gouvernement Arizona : Déconstruction des Politiques Publiques

Afin de contrer le déficit public structurel, de répondre aux trajectoires imposées par la gouvernance économique européenne et de stimuler la compétitivité macroéconomique des entreprises belges, l'accord de gouvernement "Arizona" déploie une philosophie que les observateurs politiques et académiques qualifient de réactivation coercitive de "l'État social actif".[3] Cette orientation idéologique s'accompagne d'une cure d'austérité budgétaire d'une ampleur inédite depuis les politiques de consolidation consécutives à la crise des subprimes de 2008.[3]

L'effort d'assainissement global est précisément chiffré à 23,3 milliards d'euros d'économies nettes à réaliser d'ici l'année 2029.[5] Une caractéristique fondamentale de cet accord réside dans le fait que cette consolidation budgétaire est conçue pour s'opérer sans aucune augmentation de la pression fiscale globale exprimée en pourcentage des recettes par rapport au PIB.[6] En d'autres termes, le gouvernement s'interdit de générer des recettes nouvelles massives via une taxation accrue des grands patrimoines ou des plus-values du capital, optant délibérément pour une stratégie reposant sur la réduction drastique des dépenses de fonctionnement de l'État, la limitation des dotations, et surtout la refonte structurelle des mécanismes de transferts sociaux (chômage, pensions, assurance maladie).[5] François Perl, figure reconnue de la sécurité sociale, souligne que l'accord s'appuie sur une véritable

"pathologisation de la dette" publique, présentant les dépenses de l'État social comme intrinsèquement insoutenables.[5]

La Refonte du Marché du Travail : Vers une Flexibilisation et une Dérégulation Extrêmes

Le pilier central et obsessionnel de l'action gouvernementale Arizona vise l'augmentation quantitative du volume de travailleurs actifs afin de hisser le taux d'emploi belge, historiquement stagnant autour de 72,1 % en 2023, vers le seuil ambitieux des 80 % d'ici la fin de la législature en 2029.[2] Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement introduit un arsenal législatif visant l'hyper-flexibilisation du marché du travail, s'inspirant ouvertement des modèles anglo-saxons et des rythmes de travail néerlandais.[23]

Parmi les mesures phares de dérégulation de la durée du travail, l'accord prévoit l'introduction d'un "accordéon" légal autorisant le lissage de la durée de travail hebdomadaire sur une période de référence de quatre mois. Cette disposition permettra aux employeurs d'imposer des semaines de travail s'élevant jusqu'à 48 heures lors des pics d'activité, sans déclencher le paiement de sursalaires structurels.[4] Cette mesure est combinée à une réduction du droit au repos journalier, garantissant uniquement le minimum imposé par l'Union européenne, soit 11 heures consécutives entre deux prestations, ouvrant ainsi la voie légale à des journées de travail effectif de 13 heures.[23] En outre, l'accord supprime l'obligation légale stipulant que la durée minimale d'un contrat à temps partiel doit être au moins égale au tiers d'un horaire à temps plein, précarisant considérablement les contrats de très courte durée.[4]

Parallèlement, le gouvernement institutionnalise l'extension des statuts précaires ou dérogatoires. Le plafond annuel du travail étudiant est significativement relevé, passant de 475 heures à 650 heures, permettant une substitution de main-d'œuvre structurelle par une main-d'œuvre estudiantine bon marché.[4] L'accord entérine également la généralisation du dispositif controversé des "flexi-jobs" — des emplois d'appoint faiblement taxés et partiellement exemptés des cotisations sociales patronales ordinaires — au-delà du seul secteur Horeca, pour l'étendre à de multiples branches de l'économie de services.[1] Enfin, le gouvernement instaure un contingent attractif permettant aux salariés de prester jusqu'à 360 heures supplémentaires dites "volontaires" sans motif justificatif (et jusqu'à 450 heures dans l'Horeca).[1] L'obligation de premier emploi est supprimée, et une nouvelle période d'essai de 6 mois est réintroduite, facilitant les licenciements rapides.[4] Pour stimuler l'économie, des "zones de soutien" ou "zones franches" seront créées dans les régions touchées par des licenciements collectifs, offrant des réductions structurelles du précompte professionnel aux entreprises qui s'y installent.[6]

Du point de vue strict de la santé publique et de l'ergonomie, cette atomisation du temps de travail et la précarisation juridique des statuts contractuels génèrent une pathologie sociale documentée sous le concept de "travail jetable".[26] L'imprévisibilité radicale des horaires, la

fluctuation permanente des revenus mensuels, et la dissolution des frontières entre temps professionnel et temps de récupération induisent une charge allostatique majeure. Les études épidémiologiques démontrent que les travailleurs soumis à des horaires atypiques et précaires sont statistiquement beaucoup plus sujets aux troubles musculosquelettiques (TMS), à la privation de sommeil chronique, aux dérèglements métaboliques (diabète, obésité), aux addictions compensatoires (alcool, psychotropes), et aux dépressions d'épuisement.[23] La flexibilité imposée agit comme une toxine insidieuse sur la résilience physiologique des travailleurs peu qualifiés.

La Mécanique de l'Activation : Le "Gap" Salarial et la Refonte des Filets de Sécurité

La logique d'activation du gouvernement Arizona s'appuie philosophiquement sur le concept d'incitation financière. L'accord fixe un objectif arithmétique central : créer et maintenir un écart ("gap" ou différentiel financier) incompressible de minimum 500 euros nets par mois entre les revenus d'une personne qui travaille (même à des conditions salariales modestes) et les allocations perçues par une personne sans emploi ou en situation d'inactivité.[4] Cette mesure vise à désamorcer ce que les concepteurs de l'accord nomment les "pièges à l'emploi" et à rendre le travail financièrement "rémunérateur".[28]

Pour y parvenir par le haut, le gouvernement mise sur une série de leviers d'augmentation du revenu net net du travail : une augmentation programmée du revenu minimum mensuel moyen garanti (+35 EUR nets prévus aux 1er avril 2026 et 2028, pris en charge par l'État sans surcoût direct pour les employeurs), l'adaptation de la quotité exemptée d'impôts, et surtout un renforcement substantiel du "bonus social et fiscal à l'emploi".[1] À titre d'exemple, pour les très bas salaires, ce bonus verra son pourcentage d'augmentation passer de 52,54 % à 63 % pour les exercices d'imposition 2027 et 2028 (revenus de 2026 et 2027), puis grimper jusqu'à 72 % à partir de 2029.[1] Des réductions de cotisations spéciales de sécurité sociale à charge du travailleur (notamment pour les personnes isolées) viendront compléter ce dispositif.[1]

Cependant, les organisations syndicales (FGTB, CSC), les associations de lutte contre la pauvreté (Réseau de Lutte contre la Pauvreté, CNCD 11.11.11, Ligue des Droits Humains) et de multiples observateurs sociaux dénoncent une supercherie macroéconomique : la création de cet écart de 500 euros risque d'être financée de manière disproportionnée par un nivellement par le bas, extrêmement punitif, des prestations sociales existantes.[4]

Le mécanisme fondamental de l'assurance-chômage est structurellement démoli par l'accord. La durée d'octroi des allocations d'insertion et de chômage, historiquement illimitée dans le temps en Belgique sous certaines conditions, sera désormais strictement circonscrite à une durée maximale de deux ans.[4] Une exception marginale est consentie pour les demandeurs d'emploi âgés de plus de 55 ans.[4] De surcroît, le montant de l'allocation, bien que légèrement revalorisé en tout début de période de chômage, subira une courbe de dégressivité beaucoup plus abrupte et punitive au fil des mois.[4] L'assurance-chômage perd ainsi son statut de droit

subjectif durable pour devenir un mécanisme transitoire de re-marchandisation rapide de la force de travail.[3]

En matière de droits différés et de fin de carrière, l'austérité s'illustre par l'instauration d'un mécanisme de "bonus-malus" sur les pensions légales, visant à pénaliser lourdement les départs anticipés du marché du travail.[2] Le montant de la pension de retraite subira une amputation (malus) de 2 % par année d'anticipation avant l'âge légal de la retraite pour la période allant jusqu'en 2030, puis de 4 % jusqu'en 2040, et enfin de 5 % par année à partir de 2040, et ce, pour tout travailleur ne remplissant pas la condition drastique de justifier de 35 années de carrière effective.[2] À l'inverse, un bonus symétrique est prévu pour ceux qui prolongent leur activité au-delà de l'âge légal (à condition d'avoir 35 ans de carrière).[2] L'objectif latent est de forcer la prolongation de la durée du travail d'une population vieillissante, au mépris total de l'usure professionnelle différentielle, de la pénibilité non reconnue, et de l'incapacité objective de reconversion qui frappe violemment les travailleurs manuels en fin de parcours.[4]

L'Impact Projeté de l'Austérité et de l'Activation sur les Déterminants de la Santé Publique

L'implémentation législative des réformes de la coalition Arizona déploiera ses effets systémiques les plus tangibles et les plus destructeurs entre 2026 et 2029. La modélisation croisée de ces politiques socio-économiques et des connaissances épidémiologiques permet d'anticiper avec un haut degré de certitude une série d'impacts en cascade, délétères pour la santé physique et mentale des populations d'ores et déjà précarisées.

Le Basculement vers l'Assistance : La Limitation du Chômage à Deux Ans et le Choc des CPAS

La mesure la plus disruptive, la plus commentée, et potentiellement la plus génératrice de précarité sanitaire du volet social de l'accord Arizona est sans conteste la limitation dans le temps des allocations de chômage. Les prévisions chiffrées issues du monde syndical et social anticipent des vagues massives, synchronisées et brutales de radiations des registres de l'ONEM (Office National de l'Emploi). Dès le 1er mars 2026, la "Vague 2" de la réforme entraînera la fin du droit aux allocations pour les demandeurs d'emploi se situant en 3e période d'indemnisation (allocation forfaitaire) et ayant accumulé entre 8 et 20 ans de chômage complet au cours de leur trajectoire.[35] Un mois plus tard, le 1er avril 2026, la "Vague 3" frappera ceux ayant accumulé moins de 8 ans de travail.[35] Une autre vague concernera les bénéficiaires d'allocations de garantie de revenus.[35]

Ces dizaines de milliers d'individus, subitement et unilatéralement dépourvus de leurs revenus de remplacement issus de la solidarité interprofessionnelle, n'auront d'autre recours légal pour leur stricte survie que de s'adresser au dernier filet de sécurité résiduaire de l'État belge : les

Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) de leurs communes respectives.[4] Or, le Revenu d'Intégration Sociale (RIS) octroyé par les CPAS représente un seuil de subsistance monétaire drastiquement inférieur au seuil de pauvreté européen (AROP), enfermant mécaniquement le bénéficiaire dans la privation matérielle sévère.

En mars 2026, les montants mensuels du RIS, fixés par arrêté, s'articulent selon une grille qui ne permet pas de couvrir les dépenses incompressibles de santé et de logement dans la plupart des agglomérations belges.

Catégorie Sociale du Bénéficiaire	**Montant Mensuel du RIS (Tarifs applicables au 1er Mars 2026)**	**Observations et Impacts sur le Pouvoir d'Achat Sanitaire**
Cohabitant (Catégorie 1)	893,65 €	Pour un couple cohabitant, le revenu cumulé s'élève à 1 787,30 €. Ne permet aucun investissement de santé préventive.[36]
Personne Isolée (Catégorie 2)	1.340,47 € (Base extrapolée avec aides complémentaires : ~1.476,54 €)	Plonge instantanément le bénéficiaire sous le seuil de risque de pauvreté. Arbitrages drastiques obligatoires sur la qualité alimentaire.[36]
Personne avec famille à charge (Catégorie 3)	1.811,57 €	Souvent appliqué aux familles monoparentales. Couvre à grand-peine les frais de scolarité, de logement et d'énergie, excluant les soins dentaires ou psychologiques.[36]

Sources : Consolidation des barèmes CPAS régionaux et fédéraux 2025-2026.[36]

La transition statutaire, sociologique et psychologique du statut de "chômeur indemnisé" (porteur de droits contributifs) vers celui "d'assisté social" (bénéficiaire du RIS, soumis à enquête sur les ressources) engendre une perte de revenu disponible qui percute de plein fouet les budgets vitaux de l'alimentation, du logement et de la santé.[36] Les études d'épidémiologie nutritionnelle et environnementale prouvent que la chute abrupte sous le seuil de pauvreté déclenche des arbitrages budgétaires de survie. Les ménages sacrifient en priorité

absolue l'alimentation de qualité en protéines et nutriments frais, se tournant vers l'achat de calories denses à très bas coût, favorisant l'émergence rapide de l'obésité morbide et du diabète de type 2.[14] De même, la réduction drastique du chauffage pour limiter les factures énergétiques entraîne l'apparition de moisissures dans des logements souvent insalubres, catalysant le développement de pathologies respiratoires chroniques (asthme infantile, BPCO).[14]

De surcroît, le statut même de bénéficiaire de l'aide sociale du CPAS s'accompagne d'une charge psychologique lourdement stigmatisante. Le contrôle social permanent exercé par l'administration (vérification intrusive des relevés bancaires, visites domiciliaires pour attester de la situation maritale, injonctions à l'activation) s'ajoute à la perte de l'identité professionnelle et de l'estime de soi. Cette configuration psycho-sociale multiplie les risques de dépression sévère, d'isolement total et de conduites suicidaires, un phénomène de "mort sociale" qui précède souvent la morbidité clinique.[9]

Le Lissage Temporel de l'Indice-Santé et l'Érosion Silencieuse du Pouvoir d'Achat

L'un des piliers historiques de la paix sociale et du maintien du pouvoir d'achat en Belgique réside dans le mécanisme d'indexation automatique des salaires et des allocations sociales sur l'évolution du coût de la vie. Afin de freiner la dynamique salariale au nom de l'impératif de compétitivité internationale des entreprises belges, le gouvernement Arizona a programmé une révision technique d'apparence mineure mais aux conséquences macroéconomiques dévastatrices : la modification de la méthode de calcul de l'"indice-santé lissé".

Historiquement, l'indice-santé lissé (qui sert de référence pour le dépassement de l'indice-pivot déclenchant l'augmentation des salaires publics et des prestations sociales) était calculé en prenant la moyenne arithmétique des indices des 4 derniers mois (multipliée par un facteur correctif de 0,98).[40] La réforme de l'Arizona impose que le nouveau calcul soit désormais lissé sur une période de référence étirée aux 12 derniers mois.[1]

L'impact mathématique et socio-économique de ce glissement temporel de 4 à 12 mois est sans appel : il vise délibérément à ralentir artificiellement l'ajustement des revenus face aux vagues d'inflation. À titre de démonstration, les projections économiques du PTB et des syndicats indiquent que si cette nouvelle méthode de lissage avait été appliquée rétroactivement lors des fortes poussées inflationnistes de 2023-2024, l'indexation salariale annuelle en décembre 2024 aurait été amputée, passant d'une hausse de 3,47 % (avec la moyenne sur 4 mois) à seulement 2,78 % (avec la moyenne sur 12 mois), générant une perte sèche et irrécupérable d'environ 0,7 % d'indexation pour tous les travailleurs du pays.[40]

Pour les bénéficiaires de minima sociaux de survie (allocataires du RIS, travailleurs en invalidité longue durée, bénéficiaires de pensions minimales), qui consacrent l'écrasante majorité, voire la totalité, de leur revenu nominal aux biens de consommation incompressibles et hautement

inflationnistes (énergie, alimentation de base, loyers indexés), ce retard institutionnalisé de l'indexation s'apparente à une taxe occulte. Il signifie des mois entiers passés à devoir absorber l'augmentation réelle du coût de la vie sans aucun filet de rattrapage immédiat.[42] Les syndicats et le réseau BAPN de lutte contre la pauvreté dénoncent par ailleurs que des millions de pensionnés risquent de passer à côté de revalorisations légales en raison de ces gels et lissages.[43] Ce recul continu du pouvoir d'achat réel accentue violemment l'incapacité financière des ménages à faire face aux restes à charge des soins médicaux (tickets modérateurs en augmentation, prolifération des suppléments d'honoraires dans les structures hospitalières, médicaments innovants non remboursés), amplifiant de manière dramatique la spirale du renoncement aux soins déjà minutieusement cartographiée par l'Institut Solidaris.[16]

L'Activation Coercitive des Malades de Longue Durée : La Pathologisation Sanctionnée

Dans une optique d'assainissement purement comptable, l'accord gouvernemental Arizona prend pour cible budgétaire directe l'augmentation exponentielle du nombre de travailleurs considérés comme malades de longue durée en Belgique (soit près de 500.000 citoyens bénéficiant d'indemnités d'invalidité de l'assurance maladie). La politique annoncée, rompant avec la tradition d'accompagnement médical neutre, est celle d'une "responsabilisation" de l'ensemble des acteurs de la chaîne de santé : les employeurs, les mutualités, les médecins traitants prescripteurs, et en tout premier lieu, les travailleurs malades eux-mêmes.[4]

L'accord gouvernemental prévoit l'introduction stricte de parcours obligatoires de retour au travail, adossés à la menace directe de sanctions financières punitives en cas de non-respect, même partiel, du cadre d'activation défini par l'administration.[4] En outre, l'accord restreint drastiquement le droit à la convalescence autonome en réduisant les jours de maladie sans présentation d'un certificat médical à seulement 2 fois 1 jour par an (contre 3 jours de tolérance actuellement) et en augmentant le délai de rechute de 14 jours à 8 semaines.[1] Surtout, la réforme prévoit la transformation radicale du statut du certificat d'incapacité de travail traditionnel en un "certificat électronique d'aptitude au travail" (dit "fit note"). Ce nouveau document obligera le médecin-traitant à envisager d'emblée, et formellement, des adaptations contraignantes du poste de travail pour maintenir le patient dans la sphère productive, limitant sa souveraineté d'appréciation du besoin de repos clinique total.[1]

Les professionnels de la santé publique, vigoureusement appuyés par les grands réseaux de solidarité tels que la Mutualité Solidaris, dénoncent une dérive éthique et philosophique d'une gravité exceptionnelle. Cette approche coercitive nie frontalement la réalité clinique, neurologique et physiologique de l'épuisement professionnel profond (syndromes d'épuisement ou burn-out) ainsi que la symptomatologie fluctuante des affections chroniques systémiques.[45] Elle opère un renversement idéologique pervers : elle transforme un problème de santé publique massif (les conditions de travail toxiques et l'intensification des tâches) en un prétendu défaut de volonté individuelle ou une complaisance fautive du malade.[45]

D'un point de vue épidémiologique, forcer un individu en souffrance aiguë (troubles psychiatriques graves, pathologies musculosquelettiques dégénératives, récupération oncologique) à s'inscrire dans des parcours d'activation administrative rigides expose inévitablement ce dernier à un risque clinique imminent de rechute sévère. Cette politique annihile souvent les bénéfices thérapeutiques fragiles accumulés lors des premiers mois cruciaux d'arrêt maladie. L'introduction brandie de sanctions financières amputant des indemnités d'invalidité déjà objectivement modestes poussera inexorablement les travailleurs les plus vulnérables financièrement à anticiper leur retour au travail bien avant leur guérison clinique complète. Ce phénomène de "présentéisme pathologique" ou de "retour au travail de survie" ne fera qu'accélérer la détérioration définitive et irréversible de leur capital santé, conduisant à terme à une incapacité totale et permanente, infiniment plus coûteuse pour la collectivité.[4] Jean-Pascal Labille, dirigeant de Solidaris, fustige une "stigmatisation organisée qui brouille un enjeu de santé publique majeur et divise la population", arguant que les mesures sont purement budgétaires et "ne constituent ni une politique de santé, ni une politique d'accompagnement".[45]

Conséquences Systémiques sur l'Infrastructure de Santé Publique et de Solidarité Locale

Les ondes de choc générées par les politiques macroéconomiques de l'État central ne s'arrêtent pas à la détérioration de la santé biologique des individus ; elles percutent avec une violence inouïe les institutions, les hôpitaux et les structures locales (CPAS) chargés par la Constitution de soigner, de protéger et d'accompagner la population. La stratégie d'assainissement de l'Arizona organise un définancement programmé des piliers de la solidarité.

L'Asphyxie Budgétaire Programmée des Soins de Santé (INAMI)

Le budget fédéral alloué aux soins de santé via l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) cristallise paroxysmiquement les contradictions entre la volonté politique d'austérité aveugle et la brutale réalité démographique et scientifique. Le tableau de synthèse des mesures de la coalition Arizona impose une réduction budgétaire nominale d'un demi-milliard d'euros (0,5 milliard) d'ici 2029 à l'INAMI, ce qui représente environ 2,2 % de l'effort budgétaire total demandé à la nation.[5] Plus grave encore, l'accord fixe unilatéralement la norme de croissance réelle autorisée des dépenses de santé à un plafond strict de 1 % par an.[3]

Or, les projections actuarielles des experts sanitaires et des administrateurs de la sécurité sociale, au premier rang desquels figure François Perl, démontrent implacablement que pour maintenir l'outil de santé publique à son niveau actuel de performance, face à l'hyper-inflation des coûts des nouvelles technologies médicales, à l'augmentation du prix des molécules pharmacologiques innovantes, à la chronicisation inéluctable des pathologies de longue durée et surtout au vieillissement massif et simultané de la population belge (le choc démographique du "papy-boom"), une croissance budgétaire réelle et minimale de 3,7 % par an serait

absolument impérative.[5]

Ce gouffre mathématique béant entre le 1 % de croissance concédé par le gouvernement Arizona et les 3,7 % de croissance réelle dictés par les besoins épidémiologiques garantit structurellement un sous-financement chronique, sévère et pérenne de l'ensemble du secteur de la santé, que François Perl décrit comme une véritable "asphyxie" organisée.[5] L'Institut Solidaris exigeait dans ses mémorandums la garantie absolue d'une norme de croissance minimale de 3 % pour maintenir le système à flot.[17]

Les répercussions pratiques et cliniques de cette attrition budgétaire institutionnalisée sont d'ores et déjà prévisibles et terrifiantes pour les patients. Elles se traduiront par le refus persistant ou le report continuel de l'intégration de nouvelles thérapies innovantes (notamment en oncologie de précision ou dans les maladies rares) dans la nomenclature de remboursement obligatoire. Elles forceront le gel des embauches et le non-renouvellement des effectifs de la première ligne infirmière, d'ores et déjà exsangue et au bord de l'effondrement professionnel. Elles engendreront une augmentation silencieuse mais mortelle des délais d'attente pour l'accès aux interventions chirurgicales ou psychiatriques spécialisées. Fatalement, ce définancement organisé par l'État actera l'autorisation tacite laissée aux prestataires de soins de compenser leurs pertes de revenus par une augmentation anarchique de la charge financière répercutée directement sur le patient (explosion des suppléments d'honoraires, développement d'une médecine à deux vitesses). L'Institut Solidaris avait ardemment plaidé pour l'instauration salvatrice d'un véritable "bouclier tarifaire" (dans les zones où moins de 60 % des prestataires sont conventionnés) et la suppression absolue des suppléments d'honoraires pour les bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM) ; cependant, l'étau budgétaire inflexible de l'accord Arizona rend politiquement inaudibles et financièrement impraticables de telles mesures de protection sociale vitale.[17] Cette dynamique valide la thèse avancée par de nombreux observateurs d'une "marchandisation accélérée de la Sécurité sociale", où la santé devient progressivement un bien de consommation régulé par la solvabilité individuelle plutôt que par le besoin clinique.[3]

La Surcharge Asymétrique des Entités Locales et la Crise Éthique des CPAS

La mécanique cachée des politiques d'austérité de l'État fédéral (Niveau 1) repose invariablement sur une stratégie d'externalisation furtive de la dette et de la misère sociale vers les pouvoirs publics de proximité, à savoir les Régions, les Provinces et, en fin de chaîne, les communes. Ce transfert délétère constitue un effet direct, mécanique et chiffrable de la décision de limiter strictement les allocations de chômage à deux ans. Les dizaines de milliers de personnes radiées de l'ONEM, qui basculeront inexorablement à la charge totale des CPAS à partir du printemps 2026, feront littéralement exploser les lignes budgétaires de l'assistance sociale communale.[4]

Le gouvernement De Wever assure dans sa déclaration d'intention prévoir "un refinancement

des pouvoirs locaux pour absorber l'impact des réformes du marché du travail" [47], ainsi qu'une très vague "enveloppe limitée pour les groupes les plus vulnérables".[6] Néanmoins, les projections techniques des associations de défense des droits humains (comme la Ligue des Droits Humains et le CNCD) et des fédérations de travailleurs sociaux estiment ces palliatifs financiers notoirement dérisoires, cosmétiques, et structurellement incapables d'endiguer le tsunami social annoncé par la perte des droits chômage.[9] La LDH alerte sur un "recul préoccupant pour les droits sociaux".[48]

Pour faire face à cette explosion incontrôlable et non provisionnée des dépenses de revenu d'intégration (RIS) imposées par la politique fédérale, les administrations communales se verront acculées à un dilemme tragique. Elles seront contraintes soit de procéder à la liquidation et à la réduction drastique de leurs offres de services publics locaux (fermeture de crèches de quartier, réduction des horaires des bibliothèques, abandon des infrastructures sportives publiques, suppression de l'aide ménagère et préventive à domicile pour les aînés isolés), soit d'augmenter massivement la fiscalité locale (hausse de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou explosion du précompte immobilier).[9] La population générale, et singulièrement la classe moyenne inférieure, sortira doublement perdante de cette équation : elle subira une baisse de ses revenus disponibles via l'hyper-fiscalité locale, et une dégradation profonde de son environnement urbain et préventif.[9]

Parallèlement à cet étranglement financier, le gouvernement Arizona projette de réformer la gouvernance même de l'aide sociale en instaurant un système inédit de "bonus-malus" à destination des directions des CPAS. Ce mécanisme de contrôle néolibéral liera vraisemblablement le maintien ou l'augmentation de leur dotation de subventionnement fédéral à leurs "performances" purement statistiques en matière de taux de remise à l'emploi rapide des assistés sous leur responsabilité.[28]

Cette pression hiérarchique et financière descendante exercée par l'État va transfigurer l'éthique même du travail social. Elle obligera de facto les assistants sociaux des CPAS à abandonner leur rôle d'accompagnateurs psychosociaux empathiques pour endosser les habits d'agents de contrôle répressifs et de placeurs de main-d'œuvre à bas coût.[28] Confrontés quotidiennement à la souffrance de publics lourdement carencés (problèmes psychiatriques, assuétudes, barrière de la langue, analphabétisme) qu'on leur intimera l'ordre irréaliste de propulser sur un marché du travail hyper-compétitif, les travailleurs de la première ligne sociale subiront une épidémie de dissonance cognitive. L'usure compassionnelle, les congés maladie pour dépression d'épuisement et les démissions en cascade parmi les assistants sociaux deviendront endémiques, achevant de priver les populations les plus vulnérables du dernier soutien humain nécessaire à leur maintien dans la dignité.[28]

Effets de Second et Troisième Ordre : Modélisation Prospective d'une Société Fractionnée à l'Horizon

2030

L'analyse des politiques publiques ne saurait s'arrêter aux conséquences comptables ou cliniques immédiates de l'année 2026. L'ambition d'une vision prospective à 360 degrés permet de dégager, grâce aux modélisations de l'épidémiologie sociale, les conséquences systémiques de moyen et long terme — les effets profonds de second et troisième ordre — des politiques d'austérité et d'activation coercitive sur le métabolisme global de la société belge à l'horizon de la fin de la décennie.

La Sédimentation Temporelle et la Transmission Intergénérationnelle de la Misère Sanitaire

La combinaison redoutable de l'allongement forcé de la durée de la vie active (par le recul de facto de l'âge de la retraite anticipée via des pénalités du malus atteignant jusqu'à -5 % de la pension par an [2]) et de l'injonction à l'activation permanente via des contrats précaires extrêmement flexibles (flexi-jobs, intérims atomisés, 48 heures hebdomadaires [25]) conduit inexorablement à une intensification pathologique de la vie laborieuse.

Cette configuration macroéconomique donne naissance à l'enracinement du paradoxe effrayant du "travailleur pauvre". Bien qu'actifs, les individus contraints de cumuler des "flexi-jobs" intermittents, sous-payés, sans protection conventionnelle robuste ou travaillant avec des horaires perpétuellement imprévisibles, peinent mathématiquement à générer un volume de revenus globaux capable d'extraire durablement leur ménage de la zone rouge de la privation matérielle et de la détresse énergétique.[23] L'objectif gouvernemental d'atteindre 80 % de taux d'emploi pourrait statistiquement être approché, mais au prix de la substitution d'emplois stables et protecteurs par un halo massif de sous-emplois précaires, produisant ce que le PTB et la FGTB dénoncent comme une "exploitation" organisée.[23]

Un effet de second ordre sociologiquement majeur de cet appauvrissement latent réside dans la transmission intergénérationnelle du handicap social et de la vulnérabilité biologique. Un ménage frappé par la chute sur le revenu d'assistance du CPAS, subissant l'érosion continue de son pouvoir d'achat par le lissage de l'indexation, et confronté quotidiennement à l'angoisse obsédante de la subsistance, réduit dramatiquement et mécaniquement ses investissements dans le capital éducatif, culturel et sanitaire de ses enfants. Le stress parental toxique s'infuse dans l'environnement familial, perturbant le développement cognitif des plus jeunes.

Par ailleurs, l'étude alarmante de Solidaris soulignant la hausse vertigineuse du renoncement aux soins psychologiques et psychiatriques chez les étudiants universitaires et de l'enseignement supérieur (où 26 % y renoncent pour des raisons exclusivement financières, soit une détérioration de 10 points en une seule année [17]) laisse présager une véritable épidémie sourde de décrochage scolaire, de burn-outs académiques et d'échecs universitaires. La maladie mentale non traitée ruine la capacité de concentration et de projection dans l'avenir. Ainsi, la précarité qui frappe et asphyxie l'étudiant belge aujourd'hui détruit méthodiquement

son employabilité et sa capacité d'intégration professionnelle de demain. Ce mécanisme impitoyable fige, verrouille et aggrave la reproduction sociale des immenses inégalités de santé décrites en début de rapport par la corrélation statistique implacable, documentée par Sciensano, entre l'absence de diplôme supérieur et la probabilité d'une mort prématurée évitable.[10] Le désinvestissement dans la jeunesse prépare les pathologies chroniques de la future population adulte.

La Bipolarisation Démographique de l'Espérance de Vie

Jusqu'à une époque récente, le système de sécurité sociale belge, par l'universalité historique de son maillage, parvenait tant bien que mal à maintenir un progrès continu, lent mais réel, de l'espérance de vie au sein de l'ensemble des strates de la population, y compris dans les catégories socioprofessionnelles inférieures, et ce bien que le gradient entre riches et pauvres n'ait jamais été éradiqué. Sous l'impulsion agressive de politiques néolibérales d'austérité qui accélèrent la marchandisation insidieuse de la sécurité sociale, détricotent l'assurance chômage et plafonnent l'enveloppe de l'assurance maladie [3], la démographie belge risque de connaître un effet de troisième ordre inédit, documenté dans d'autres nations ayant adopté ces thérapies de choc (comme le Royaume-Uni post-2010) : la divergence radicale et la bipolarisation des trajectoires d'espérance de vie.

D'une part, les classes supérieures, les professions intellectuelles et les classes moyennes supérieures très aisées continueront de bénéficier pleinement des avancées formidables de la médecine prédictive et des thérapies géniques coûteuses. Fortes de leur capital et protégées par des polices d'assurances complémentaires privées onéreuses, elles seront parfaitement capables d'absorber l'inflation galopante des suppléments d'honoraires et le coût des médicaments de pointe non remboursés par un INAMI sous-financé. Leur espérance de vie en bonne santé continuera sa progression vers des sommets inédits.

D'autre part, les populations marginalisées par les réformes — les dizaines de milliers de chômeurs de longue durée brutalement radiés et transférés aux CPAS, les familles monoparentales définitivement piégées sous le seuil de pauvreté dans l'assistance [4], et les cohortes de "travailleurs jetables" précaires physiquement abîmés et épuisés par les semaines de 48 heures erratiques imposées par l'accord [23] — pourraient voir la progression de leur espérance de vie stagner brutalement, voire s'inverser et régresser. Le renoncement forcé aux soins primaires de prévention [17], couplé à l'explosion non contenue des maladies métaboliques et des troubles mentaux chroniques sévères — particulièrement mal pris en charge par une première ligne psychiatrique asphyxiée financièrement — se solderont inévitablement par une explosion statistique des événements critiques évitables. Les infarctus du myocarde fulgurants, les suicides de désespoir, les pathologies hépatiques liées à l'alcoolisme compensatoire, et la détection de cancers à un stade métastatique terminal faute de dépistage précoce, se concentreront et sur-sélectionneront avec une violence inouïe les déciles les plus pauvres de la population belge.

L'Impact Géopolitique Interne : L'Asymétrie Territoriale et la Rupture de la Cohésion Nationale

Enfin, cette dynamique mortifère d'appauvrissement programmé aura un effet d'écartèlement institutionnel, financier et territorial majeur, menaçant la stabilité même du modèle étatique. La Belgique, en tant qu'État fédéral d'une rare complexité, affiche des réalités macroéconomiques et démographiques structurellement et historiquement contrastées. Les asymétries sont béantes entre, d'un côté, la Région flamande (qui concentre le tissu industriel performant et affiche la meilleure espérance de vie du pays, à 84,1 ans [10]) et, de l'autre côté, la Région Wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, territoires lourdement meurtris par la désindustrialisation, où le taux de pauvreté endémique et le taux de chômage sont structurellement, et de très loin, plus élevés qu'au Nord.[10]

L'imposition uniforme par le gouvernement Arizona de règles fédérales extrêmement strictes et punitives — telles que la limitation radicale du chômage à deux ans et l'instauration coercitive du bonus-malus conditionnant le subventionnement des CPAS [9] — frappera avec une intensité asymétrique foudroyante le sud du pays et la capitale. Les communes bruxelloises (déjà en quasi-faillite structurelle) et les communes des anciens bassins industriels wallons (Hainaut, Liège) s'appauvriront beaucoup plus rapidement et beaucoup plus violemment sous le poids colossal des milliers d'assistés transférés depuis le chômage fédéral.

Cette asymétrie de l'impact des réformes créera une boucle de rétroaction négative auto-réalisatrice à l'échelle des territoires : des communes financièrement saignées à blanc par les charges d'aide sociale seront obligées de rogner sur tout le reste. Elles offriront inéluctablement de pires infrastructures de prévention santé, des cadres de vie urbains dégradés, et des réseaux d'éducation ou d'accueil de la petite enfance délabrés. Cet environnement appauvri détériorera encore davantage la santé physique et mentale globale de leurs habitants (renforçant le gradient provincial déjà observé par Sciensano [10]), réduisant à néant leur fragile "employabilité" locale. En outre, la densification de la précarité extrême, combinée au désinvestissement dans les services publics d'encadrement social, favorise historiquement l'augmentation de l'économie de la débrouille, du travail au noir (pointé comme cible par l'Arizona [26]), de la criminalité de survie et des incivilités liées à l'anomie et à la détresse sociale absolue.

Dès lors, la logique froide d'austérité budgétaire aveugle, pensée dans les cabinets ministériels fédéraux, se transforme inéluctablement en un formidable moteur de crise institutionnelle et de fragmentation définitive du tissu national et de la solidarité interrégionale. Elle alimente au passage, de manière pernicieuse, le ressentiment viscéral, la colère populaire et l'éloignement démocratique massif des populations défavorisées et stigmatisées (fustigées comme de mauvais élèves de l'activation) vis-à-vis d'un appareil d'État central perçu désormais comme une entité purement punitive, sourde à la détresse sanitaire et sociale de ses composantes les plus fragiles.[8] Les leaders associatifs et syndicaux, à l'instar d'Arnaud Zacharie (CNCD), décrivent d'ailleurs ces réformes de l'Arizona non pas comme une solution, mais comme "le

symptôme d'un monde en crise", alertant sur les glissements autoritaires inhérents à de telles régressions des droits.[31]

Conclusion et Synthèse Analytique Fondamentale

La relation intime et complexe qui unit la précarité matérielle et l'état de santé biologique ou mental ne saurait en aucun cas se résumer à une simple variable d'ajustement comptable ou à un banal constat sociologique de marge. Elle constitue, au contraire, la trame fondamentale, le ciment silencieux sur lequel s'évalue et se juge la véritable résilience d'une démocratie, l'efficience de son système de sécurité sociale, et la durabilité de son modèle de croissance. La vision panoramique à 360 degrés de l'état de la Belgique, modélisée à l'aube de l'ère des réformes du gouvernement "Arizona" (2025-2029), met en lumière avec une crudité inquiétante la collision frontale, inéluctable et destructrice, entre deux forces antagonistes et irréconciliables.

D'une part, nous observons une réalité de terrain épidémiologique et sociale déjà profondément fracturée. Cette réalité est caractérisée par une usure psychologique généralisée de la population (le bien-être au plus bas depuis deux décennies [20]), par l'explosion silencieuse mais chiffrée du renoncement aux soins essentiels chez les étudiants et les familles monoparentales piégées dans la survie [17], et par la prégnance absolue et mortifère des inégalités sociales de santé qui amputent de près d'une demi-décennie l'espérance de vie des citoyens des provinces désindustrialisées.[10]

D'autre part, face à cette vulnérabilité biologique et sociale qui exigerait des investissements massifs de résilience, s'érige une doctrine politique d'hyper-compétitivité assumée et décomplexée. Cette doctrine, justifiée par l'urgence d'un assainissement de 23,3 milliards d'euros, vise à rationaliser drastiquement les finances publiques en opérant une révolution philosophique majeure : elle choisit de traiter l'immense machinerie de la protection sociale non plus comme un droit constitutionnel inaliénable garantissant la santé et la dignité citoyennes, mais exclusivement comme un centre de coût économique improductif qu'il convient désormais de conditionner sévèrement, de limiter dans le temps, d'activer par la contrainte et de soumettre aux forces dérégulées du marché.[8]

L'accord de coalition Arizona, par ses mesures phares d'éviction massive et planifiée des chômeurs vers le gouffre sous-financé des CPAS locaux (le RIS isolé ne couvrant même pas 1500 euros [38]), son lissage opportuniste de l'indexation réduisant subrepticement le pouvoir d'achat réel de la population [40], sa flexibilisation du temps de travail poussée jusqu'aux extrêmes marges de la tolérance physiologique et ergonomique humaine (les fameuses semaines de 48 heures d'amplitude et les heures supplémentaires non régulées [24]), et son définancement institutionnalisé, chronique et largement insuffisant du secteur vital de la santé (imposant arbitrairement une norme de croissance de 1 % pour l'INAMI face à des besoins épidémiologiques et démographiques incontestables de 3,7 % [5]), organise rien de moins qu'un

déplacement systémique et silencieux du risque sociétal.[3] L'État central, obsédé par l'orthodoxie de ses équilibres budgétaires et son rating international [51], opère une retraite stratégique d'une violence inédite, renvoyant cyniquement la double charge de la dette financière et de la détresse pathologique vers les bilans exsangues des autorités locales et, *in fine*, vers les corps et les esprits des individus les plus précaires de la société.[9]

Dans la stricte perspective épistémologique et clinique de la santé publique, il est impératif pour la communauté scientifique et les observateurs sociaux d'affirmer avec la plus grande fermeté que les politiques macroéconomiques de retour forcé et indiscriminé à l'emploi (l'"activation" néolibérale) menées par le seul biais de l'étranglement monétaire, de l'injonction punitive, de l'appauvrissement des malades et de la menace de la privation (le gap de 500 euros financé par le bas [4]), ne génèrent en aucune manière un capital humain solide, productif et durable.[23] Elles génèrent et modèlent, au contraire, une "main-d'œuvre de survie" angoissée, structurellement désengagée, éminemment prompte à l'épuisement précoce, dramatiquement vulnérable aux accidents du travail en raison de la fatigue et de la précarité des contrats [23], et fatalement sujette au développement accéléré de pathologies chroniques somatiques ou psychiques lourdes et invalidantes.

Afin de contrer cet effondrement programmé des filets de prévention sanitaire et d'éviter un désastre épidémiologique à long terme dont le coût de prise en charge en urgence dépassera allègrement les maigres économies réalisées sur le dos de l'assurance-chômage et des pensions, la rigueur de l'analyse suggère l'urgence absolue de mettre en œuvre des mesures socio-économiques résolument contre-cycliques. Telles que le préconisent de façon unanime les observatoires de santé, la mutualité Solidaris, et les acteurs de la société civile : l'instauration législative immédiate d'un véritable bouclier tarifaire garantissant l'accessibilité financière inconditionnelle de l'entièreté de la médecine de première ligne, la suppression immédiate et définitive des limites drastiques d'accès aux séances de psychologues pour les étudiants et les mineurs en souffrance, ainsi qu'une sanctuarisation juridique absolue du revenu minimum d'intégration (RIS) octroyé par les CPAS, afin de le hisser obligatoirement, de manière pérenne et automatique, au-dessus du seuil de pauvreté européen (AROP).[4]

En l'absence persistante de la volonté d'appliquer de telles corrections structurelles visant à recréer de l'équité, la Belgique de l'année 2029 pourra peut-être s'enorgueillir de présenter des finances publiques formellement apaisées, respectueuses des diktats comptables européens au niveau exclusif de l'administration centrale. Cependant, cette vitrine macroéconomique polie dissimulera de facto un passif socio-sanitaire abyssal et terrifiant, accumulé dans l'ombre par le désespoir quotidien. Cette Belgique post-Arizona sera irrémédiablement caractérisée par une population globalement plus épuisée, beaucoup plus sévèrement malade, infiniment plus divisée institutionnellement, et au sein de laquelle des millions de citoyens — les segments les plus vulnérables du peuple belge — auront vu leur droit inaliénable et constitutionnel à jouir de la meilleure santé possible et de l'espérance de vie la plus longue, purement, simplement, et irrévocablement sacrifié sur l'autel de l'austérité budgétaire aveugle.

Sources des citations

1. Accord du gouvernement fédéral : les mesures prévues par l'Arizona impactant les employeurs | UCM, consulté le mars 2, 2026, https://www.ucm.be/actualites/accord-du-gouvernement-federal-les-mesures-prevues-par-larizona-impactant-les-employeurs
2. Arizona. Tour d'horizon des mesures sociales phares de l'accord de gouvernement., consulté le mars 2, 2026, https://blog.forumforthefuture.be/fr/article/arizona.-tour-dhorizon-des-mesures-sociales-phares-de-laccord-de-gouvernement./25972?params=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiWlR4VVBtUHBCWkhzZlVYN3JObWowKzhMQXJHMUJZMml4YW1tK0ZGcmpZbFI1MzJGbHprakV5OTlnRE90TkdKVFphUUhmU3hGNjRYc25sbGllYzZ5NmQxYkhpQk5YdWpncG03NEI3azRsUFU9IiwiaXYiOiJhODZjZTM1NjI3OGNiNzFjMmRiYjA4NjNiNDY5NDA1NSIsInNhbHQiOiIwNDU4YjEzMDI3MDRmNDAzNTQ5YmE1YjAyYzMyMjdiZWM2ZjlkZDdjNmYyMjFjODkyOTQ4NjU1ODVmYzQzMjNmZTM2NjFlMWRhNjQ3ZDczOTcxMGFiYjY3Mzc3MTU0MzM3ZDg4ZDYxYmU0YzlmMzFjOWEzYzc1YzkzOTE1NDUzMTBjNjJmOTljNDhjYTdiMGJiNzA1NDc3N2U4YjU5YmYwMzNhZTVkMjhkZjBiMjlhNGE3MzgyNTBhNjRjY2E5MTQ3ZjU5ZmUxMjdkYTUzM2YwYTAwM2E4NWI2Y2U5ODI5NjEyOGJlYjY5ODVmZjY0NTU4YWRjNTcyMjIxYWI5Yjk5MjgyNjQ1ZDA4ODUwM2I4YWVhNTEzYmY2ODQzMmNlZGIwNDkwZWNiNmJlZjAxMGM0MzE4NTVlM2Y2MDFjMGVmNTBkNzE3MmEzMTYwMzlhNTFjYmYwMGJjYWIzNzYzZjUzNGFlNzVmYmM2MjhhYjE4NDdhNTNjMTlmYzU1MzQ1NTEwYmRkOGUyNzBhYWRjYzIyNDI0YTAyMzRjNDBhNjIzODMxMDI5ZDdiYmZlYTkwZmMxNjMwZjI3NjJkZWMwMWMxNDA2Njc4N2NiNGNiMWVmZDg3ZjFjMDBlODkxODQ1NmQxY2IzM2I5ZDFiMWMzNWM1MThlM2NlMTYxNmUzZDRjOCIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0
3. Décoder l'Arizona (2/4) : la marchandisation accélérée de la Sécurité sociale - Politique, consulté le mars 2, 2026, https://www.revuepolitique.be/decoder-larizona-2-4-la-marchandisation-acceleree-de-la-securite-sociale/
4. Accord de gouvernement Arizona - sninet.be, consulté le mars 2, 2026, https://www.sninet.be/fr/accord-de-gouvernement-arizona
5. Décoder l'Arizona (1/4) : austérité budgétaire et compétitivité ..., consulté le mars 2, 2026, https://www.revuepolitique.be/decoder-larizona-1-4-austerite-budgetaire-et-competitivite/
6. ACCORD DE COALITION FÉDÉRALE 2025-2029 - Belgium.be, consulté le mars 2, 2026, https://www.belgium.be/sites/default/files/resources/publication/files/Accord_gouvernemental-Bart_De_Wever_fr.pdf
7. ACCORD DE COALITION FÉDÉRALE 2025-2029 - Ligue des droits humains, consulté le mars 2, 2026, https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2025/02/Accord-de-majorite%CC%81-ARIZONA-FR-DEFINITIVE.pdf
8. Gouvernement Arizona : un naufrage social au profit des plus riches ! - Liages -, consulté le mars 2, 2026,

https://www.liages.be/gouvernement-arizona-un-naufrage-social-au-profit-des-plus-riches/
9. Quel droit à l'aide du CPAS pour les chômeur·ses exclu·es ? Quelles conséquences, consulté le mars 2, 2026, https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2025/06/Article-4-Chronique-211.pdf
10. Life Expectancy and Quality of Life - Vers une Belgique en bonne santé, consulté le mars 2, 2026, https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/life-expectancy-and-quality-of-life?highlight=WyJjcmVhdGVkIiwiZGF0ZSIsInZhYXR6aWVrdGVuIiwicmVzcGlyYXRvaXJlIiwicmVzcGlyYXRvaXJlcyIsInJlc3BpcmF0b3J5IiwiY29uc29tbWF0aW9uIiwidW5jYXRlZ29yaXNlZCIsInN0YXR1cyIsInBvcHVsYXRpb24iXQ==
11. La Belgique enregistre une légère sous-mortalité en 2024 - sciensano.be, consulté le mars 2, 2026, https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/la-belgique-enregistre-une-legere-sous-mortalite-en-2024
12. Sciensano : "Un décès sur cinq en Belgique est lié à la précarité sociale"., consulté le mars 2, 2026, https://lejournaldumedecin.pmg.be/fr/fichier/EAKbe2550S64_00
13. Espérance de vie - Vers une Belgique en bonne santé, consulté le mars 2, 2026, https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/esperance-de-vie-et-qualite-de-vie/esperance-de-vie?highlight=WyJjYXRcdTAwZTlnb3JpZSIsImNhdFx1MDBlOWdvcmllcyIsImNhdFx1MDBlOWdvcmlzYXRpb24iLCJtYWxhZGUiLCJkaXNvcmRlcnMiLCJkZW1lbmNlcyIsImRlbWVudGlhIiwiZGVtZW50aWUiLCJkZSIsImtpbmRlcmVuIl0=
14. Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | Statbel, consulté le mars 2, 2026, https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale
15. Actualisation de l'Indice de Situation Sociale de la Wallonie (ISS – 12e exercice-2025) - Iweps, consulté le mars 2, 2026, https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2025/12/RR65.pdf
16. Report ou annulation de soins de santé pour raisons financières (i07) - indicators.be -, consulté le mars 2, 2026, https://www.indicators.be/fr/i/G01_PHC/Report_ou_annulation_de_soins_de_sant%C3%A9_pour_raisons_financi%C3%A8res_%28i07%29
17. Le report des soins de santé – Edition 2025 – Institut Solidaris, consulté le mars 2, 2026, https://www.institut-solidaris.be/index.php/etudes/medecine/barometre-dossier-medical-global-2012/report-soins-2025/
18. Renoncement aux soins pour raisons financières - Institut Solidaris, consulté le mars 2, 2026, https://www.institut-solidaris.be/wp-content/uploads/2024/12/Report-de-soins-2024-VF.pdf
19. Près d'un étudiant sur deux renonce à au moins un soin - Solidaris Wallonie, consulté le mars 2, 2026, https://www.solidaris-wallonie.be/communique-de-presse/report-de-soins-dece

mbre-2025
20. Baromètre du bien-être : les résultats | SPF Santé publique - Belgium.be, consulté le mars 2, 2026, https://www.health.belgium.be/fr/actualites/2025-9-barometre-bien-etre-resultats
21. Le bien-être des Belges au plus bas depuis 20 ans | En Marche, consulté le mars 2, 2026, https://www.mc.be/en-marche/sante/sante-mentale/le-bien-etre-des-belges-au-plus-bas-depuis-20-ans
22. Re-InVEST.be Politiques de santé et lutte contre la pauvreté : une analyse sous l'angle des - Belspo, consulté le mars 2, 2026, https://www.belspo.be/belspo/brain2-be/projects/FinalReports/Re-InVEST-be_PolicyBrief-3_fr.pdf
23. L'Arizona démasqué | Déréguler, précariser, isoler et sanctionner : les quatre leviers du gouvernement pour casser nos conditions de travail | PTB, consulté le mars 2, 2026, https://www.ptb.be/arizonademasque/dereguler-precariser-isoler-sanctionner
24. Chapitre 1 : Le plan de l'Arizona contre nos salaires - PTB, consulté le mars 2, 2026, https://www.ptb.be/chapitre-1-le-plan-de-larizona-contre-nos-salaires
25. 10 points clés de l'accord de coalition Arizona qui impacterons le droit du travail, consulté le mars 2, 2026, https://www.loyensloeff.com/fr/insights/news--events/news/10-points-cles-de-laccord-de-coalition-arizona-qui-impacterons-le-droit-du-travail/
26. Arizona : Intérimaires, jobs précaires, travail au noir ... les grandes cibles du gouvernement, consulté le mars 2, 2026, https://bruxellesdevie.com/2025/11/25/arizona-interimaires-jobs-precaires-travail-au-noir-les-grandes-cibles-du-gouvernement/
27. Cycle de rencontres 2026 : L'horizon Arizona - Atelier des Droits Sociaux, consulté le mars 2, 2026, https://ladds.be/cycle-de-rencontres-arizona-a-l-horizon/
28. Accord du Gouvernement « Arizona » : impacts directs et indirects sur les CPAS, consulté le mars 2, 2026, https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/article/l-accord-du-gouvernement-arizona-impacts-directs-et-indirects-sur-les-cpas
29. Renforcement du bonus à l'emploi à partir de 2026 : qu'est-ce qui va changer pour les travailleurs à bas salaires ? | Liantis, consulté le mars 2, 2026, https://www.liantis.be/fr/nouvelles/renforcement-du-bonus-%C3%A0-l%E2%80%99emploi-%C3%A0-partir-de-2026-qu%E2%80%99est-ce-qui-va-changer-pour-les
30. Le bonus à l'emploi au 1er janvier et 1er mars 2026 - Partena Professional, consulté le mars 2, 2026, https://www.partena-professional.be/fr/nos-connaissances/infoflashes/le-bonus-l-emploi-au-1er-janvier-et-1er-mars-2026
31. L'Alliance des résistances contre l'Arizona : Syndicats et société civile unis contre l'austérité et la régression des droits - CSC, consulté le mars 2, 2026, https://www.lacsc.be/page-dactualites/2025/10/07/l'alliance-des-r%C3%A9sistan

ces-contre-l'arizona---syndicats-et-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-unis-contre-l'aust%C3%A9rit%C3%A9-et-la-r%C3%A9gression-des-droits
32. Mesures d'austérité : il y a toujours des alternatives ! - CNCD, consulté le mars 2, 2026, https://www.cncd.be/Mesures-d-austerite-il-y-a
33. Accord Arizona : une menace grave pour la prospérité et le bien-être de toutes et tous., consulté le mars 2, 2026, https://www.lacsc.be/page-dactualites/2025/02/01/accord-arizona-une-menace-grave-pour-la-prosperite-et-le-bien-etre-de-toutes-et-tous
34. Belgique : Un accord trouvé par le gouvernement fédéral - RTBF Info - YouTube, consulté le mars 2, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=OO-r4kBQMt4
35. Réforme de l'assurance chômage - Office national de l'emploi, consulté le mars 2, 2026, https://www.onem.be/reforme-de-la-reglementation-du-chomage
36. Quelles sont les catégories et les montants du revenu d'intégration (RIS) et de l'aide sociale et que se passe-t-il si on a des revenus par ailleurs - Bruxelles-J, consulté le mars 2, 2026, https://www.bruxelles-j.be/droits-sociaux/obtenir-de-laide-du-cpas/quels-sont-les-categories-et-les-montants-du-revenu-dintegration-et-de-laide-sociale-et-que-se-passe-t-il-si-on-a-des-revenus-par-ailleurs/
37. Tableau récapitulatif des montants - 01/03/2026 - UVCW, consulté le mars 2, 2026, https://www.uvcw.be/aide-sociale/etudes/art-3768
38. Montants RIS | Primabook, consulté le mars 2, 2026, https://primabook.mi-is.be/fr/droit-lintegration-sociale/montants-ris
39. Aides - Revenus et allocations - CPAS d'Evere, consulté le mars 2, 2026, https://cpasevere.brussels/aides/revenus-allocations/
40. Arizona - PTB, consulté le mars 2, 2026, https://assets.ptb.be/2024-10/a4brochure-arizonasfrv31102024-sm7u6o.pdf
41. Indice santé | Statbel, consulté le mars 2, 2026, https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-sante
42. Indexation des prestations sociales | Service Public Fédéral - Belgium.be, consulté le mars 2, 2026, https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/publications-statistiques/indexation-des-prestations-sociales
43. Syndicats magazine #5//2025 - FGTB, consulté le mars 2, 2026, https://fgtb.be/publication/syndicats-magazine-52025
44. Les indicateurs sociaux dans l'Union européenne : avancement et perspectives - Drees, consulté le mars 2, 2026, https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/dss02-2004.pdf
45. Maladies de longue durée : le travail en cause, pas les travailleurs - Solidaris Wallonie, consulté le mars 2, 2026, https://www.solidaris-wallonie.be/communique-de-presse/le-travail-en-cause-pas-les-travailleurs
46. Résumé et enjeux de l'Accord Arizona concernant la santé mentale, consulté le mars 2, 2026, https://lbsm.be/IMG/pdf/250204_resume_et_enjeux_accord_federal_vf.pdf
47. DÉCLARATION DU FORMATEUR 2025-2029 - Tamtam.pro, consulté le mars 2,

2026, https://s3.tamtam.pro/production/storage/media/PDF/46649/225a3ecab0a6dfb3402caac7c13fd855d85630bc.pdf
48. Accord « Arizona » : recul préoccupant pour les droits sociaux et droits des étranger·ères et tournant sécuritaire confirmé, consulté le mars 2, 2026, https://www.liguedh.be/accord-arizona-recul-preoccupant-pour-les-droits-sociaux-et-droits-des-etranger%C2%B7eres-et-tournant-securitaire-confirme/
49. BAROMÈTRE - FGTB, consulté le mars 2, 2026, https://fgtb.be/sites/default/files/2025-12/FGTB%20Barome%CC%80tre%202025%20FR.pdf
50. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté et des inégalités sociales ..., consulté le mars 2, 2026, https://www.vivalis.brussels/fr/publication/2025-rapport-bruxellois-pauvrete-inegalites-social-sante
51. Réaction à l'accord de majorité Arizona - Sarah Schlitz |, consulté le mars 2, 2026, https://sarahschlitz.be/reaction-a-laccord-de-majorite-arizona/